

Die Pflegefachkraft schätzt zu Beginn des pflegerischen Auftrages beim Schmerzassessment folgende Kriterien ein:

- in welchem Ausmaß ist der Mensch situativ dazu in der Lage, sprachlich Auskunft zu seinen Schmerzen zu geben,
- kulturelle und soziale Faktoren,
- Risikofaktoren für das Auftreten von Schmerzen,
- verbale, nonverbale, verhaltensbezogene und physiologische Anzeichen für Schmerzen

Die Pflegefachkraft erkennt ob der Mensch **akute und chronische Schmerzen** hat.

Erfasst wird:

- die zeitliche Dimension und das Auftreten, d.h. den Beginn, die Dauer, der Schmerzen insgesamt und ggf. einzelner Episoden, sowie deren Varianten, Rhythmen und Verlaufsmuster,
- die Schmerzintensität und das individuell akzeptable Schmerzmaß,
- die Schmerzlokalisierung(-en), Anzahl und Ausstrahlungsmuster, z. B. anhand eines Körperschemas,
- die Schmerzqualität, z. B. stechend, pochend, brennend, elektrisierend oder einschießend,
- begleitende Symptome, z. B. Taubheit, Hyperalgesie, veränderte Sensitivität, Müdigkeit,

Schwitzen, Erbrechen und Schlafstörungen, Angst oder depressive Verstimmungen,

- die Bedeutung, die der Mensch mit Schmerzen dem Schmerzerleben beimisst,
- Schmerz verstärkende und lindernde Faktoren,
- Effekte des Schmerzes auf die Lebensqualität, körperliche Funktionsfähigkeit und soziale Teilhabe,
- Schmerzmedikamentengebrauch (dazu zählen auch freiverkäufliche Präparate) sowie Stimmungslage

stabilen Schmerzsituation:

- Wenn eine Schmerzsituation ohne Überschreiten des individuellen Schmerzmaßes vorliegt oder die Fremdeinschätzung und die damit verbundene Analyse des Verhaltens bzw. der Verhaltensveränderungen keinen Verdacht auf Schmerzen nahelegen,
- eine abhängig von der gesundheitlichen Situation akzeptable Funktionalität und Mobilität vorliegt,
- für mögliche Krisen und Komplikationen Strategien zur Bewältigung bekannt sind,
- keine unerwünschten Nebenwirkungen der Therapien und Komplikationen der Erkrankung auftreten.

instabilen Schmerzsituation bei chronischen Schmerzen

- die Schmerzsituation und -linderung dauerhaft nicht einer akzeptablen Situation entspricht,
- gesundheitsbezogene oder alltagsbezogene Krisen auftreten oder noch nicht wieder durch eine akzeptable Situation abgelöst wurden,
- Versorgungsbrüche entstehen, die nicht mit Hilfe von Selbstmanagementkompetenz, familiäre oder professioneller Unterstützung überbrückt werden können,
- Komplikationen mit der oder durch die Therapie oder deren Nebenwirkungen auftreten,
- durch die Schmerzsituation eine Einbuße an Lebensqualität, Funktionalität oder sozialer Teilhabe entstanden ist, die nicht mehr dem direkt geäußerten oder mutmaßlichen Willen des Menschen mit Schmerzen entspricht. Besonders der Prozess der langsamen Verschlechterung des Gesundheitszustandes fordert von Pflegefachkräften, eine regelmäßige kritische Reflektion der Schmerzsituation vorzunehmen.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	1	Verw./MA

Geplant werden:

- Nicht-medikamentöse Maßnahmen
- Medikamentöse Maßnahmen
- Schmerzlindernde Faktoren
- Vermeidung von Schmerz verstärkenden Faktoren
- Schmerz stabilisierende Faktoren
- Unterstützung bei der psychischen Belastung
- Unterstützung bei dem Alltag beeinflussende Schmerzen
- Aktivierungsmaßnahmen
- Schulungsmaßnahmen (auch der Angehörigen)
- Therapie (nur das eine stattfindet, Inhalt plant der Therapeut)